Клинические рекомендации

Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.0** — Абсцесс, фурункул и карбункул носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/956_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Причины 3

2.3 Почему фурункул носа опасен 3

2.4 Классификация 4

2.5 Клиническая картина 4

2.6 Анамнез 4

3. Диагностика 4

3.1 Осмотр 5

3.2 Признаки внутричерепных осложнений 5

3.3 Анализы 6

4. Лечение 6

4.1 Местное лечение 6

4.2 Обезболивание 7

4.3 Обезболивание у взрослых 7

4.4 Обезболивание у детей 7

4.5 Системные антибиотики 8

4.6 Парентеральные антибиотики 9

4.7 Антикоагулянты 10

4.8 Хирургическое лечение 10

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 10

5.1 Рецидивы 10

5.2 Профилактика 11

5.3 Госпитализация 11

6. Источник и актуальность **11**

6.1 Неточности в самом тексте КР 11

1. Главное

- В стадии инфильтрации фурункул лечат консервативно; при абсцедировании и при карбункуле гнойник вскрывают и дренируют, продолжая консервативное лечение.
- Системные антибиотики назначают всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа — чтобы санировать очаг и предупредить осложнения.
- При каждом осмотре ищут признаки внутричерепных осложнений: синдром системной воспалительной реакции, неврологические и глазные симптомы, тромбоз угловой вены и кавернозного синуса.
- Лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и поражение III, IV, V и VI пар черепных нервов указывают на возможный тромбоз кавернозного синуса; в этом случае делают КТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.
- Ребёнка с этим диагнозом всегда госпитализируют в круглосуточный ЛОР-стационар; взрослого в стадии инфильтрации можно лечить амбулаторно.
- Массировать область носа и выдавливать содержимое фурункула нельзя.

2. Клиника и классификация

2.1 Определения

Фурункул носа — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы на кончике или крыльях носа, в преддверии носа или в области дна носа у верхней губы. Карбункул носа — гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желёз, которое распространяется вглубь тканей и по поверхности, с обширными некрозами кожи и подкожной клетчатки. Абсцесс носа (абсцедирующий фурункул) — скопление гноя при острой инфекции с разрушением тканей в очаге, часто с отёком вокруг.

2.2 Причины

Главный возбудитель — золотистый стафилококк; бессимптомные носители служат резервуаром инфекции. Пиодермию и фурункул носа могут вызывать и стрептококки, прежде всего бета-гемолитический стрептококк группы А. Инфицированию фолликула способствуют микротравмы кожи носа и преддверия, загрязнение кожи техническими маслами и пылью при плохой гигиене, а также переохлаждение, перегревание, стресс и нарушение секреции кожи. У детей фурункул чаще всего возникает из-за привычки ковырять в носу и слишком частого сморкания.

Фурункул носа нередко бывает проявлением фурункулёза — множественных фурункулов на фоне вторичного иммунодефицита при эндокринных болезнях, прежде всего при сахарном диабете, а также при гиповитаминозе, нарушениях питания и болезнях желудочно-кишечного тракта.

2.3 Почему фурункул носа опасен

Венозная кровь от средней зоны лица — так называемого опасного треугольника, ограниченного линиями от назиона к углам рта, — оттекает по угловым венам, венам орбиты и крыловидному сплетению в кавернозный синус. У этих вен нет клапанов, поэтому инфекция с кожи лица, носа и пазух может по сосудам попасть в глазницу, затем в кавернозный синус и на мозг. В кавернозном синусе проходят внутренняя сонная артерия, III, IV и VI пары черепных нервов и первая и вторая ветви тройничного нерва, к нему прилежат гипофиз и клиновидная пазуха; отсюда тяжесть внутричерепных осложнений.

При сниженной сопротивляемости и высокой вирулентности возбудителя процесс может генерализоваться: стафилококки распространяются в окружающие ткани или попадают в кровь и вызывают сепсис. В инфильтрате тромбируются мелкие вены, и с ростом очага растёт угроза распространения тромбоза.

2.4 Классификация

По стадии воспаления выделяют I стадию — инфильтрации и II стадию — абсцедирования.

2.5 Клиническая картина

Пациенты с фурункулом носа жалуются на боль в области носа, головную боль, слабость, снижение работоспособности и субфебрильную температуру. В анализе крови может быть сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышенная СОЭ. Фурункул бывает на кончике носа, в преддверии, у перегородки или в области дна носа.

> В разделе 1.6 сказано, что фурункул бывает «в области дна носа у нижней губы», а в определениях (раздел 1.1 и «Термины») — «у верхней губы». Дно носа граничит с верхней губой, так что в разделе 1.6, по-видимому, опечатка.

В стадии инфильтрации кожа над фурункулом постепенно краснеет, появляется местная боль, которая усиливается при мимике и жевании, нарастает инфильтрация мягких тканей. Вокруг очага образуется некроз, формируется стержень. На внутренней поверхности входа в нос виден болезненный конусовидный инфильтрат.

При благополучном течении некротический стержень отторгается, выделяется немного гноя, инфильтрат уменьшается, боль стихает, температура нормализуется и общее состояние улучшается.

В стадии абсцедирования, если процесс прогрессирует, зона некроза растёт, кожа над инфильтратом истончается, появляется флюктуация и формируется абсцесс.

При карбункуле и абсцессе носа общее состояние тяжёлое, температура фебрильная, пациента беспокоят распирание и сильная пульсирующая боль. На носу появляется несколько плотных инфильтратов, которые сливаются в один растущий очаг. В области карбункула образуется большая полость с гнойно-некротическим содержимым, а на коже — несколько отверстий, из которых выделяются гной и некротические кровянистые массы.

У детей болезнь протекает тяжелее из-за интоксикации: головной боли, слабости, вялости, лихорадки. Местные изменения могут развиваться быстрее, а обширный отёк и покраснение верхней губы или щеки могут маскировать фурункул под болезнь челюстно-лицевой области.

2.6 Анамнез

В анамнезе бывают переохлаждение и косметические процедуры на наружном носе и в его преддверии.

---

3. Диагностика

Диагноз фурункула носа ставят по трём признакам. Первый — жалобы на сильную боль в носу в области очага, которая усиливается при прикосновении, головную боль, недомогание и повышение температуры. Второй — данные осмотра: покраснение, отёк и инфильтрация мягких тканей наружного носа, преддверия и носо-лицевой области, резкая болезненность при пальпации. Третий — данные передней риноскопии: в преддверии носа у волосяного фолликула видны покраснение кожи, инфильтрат и гнойный стержень в центре.

3.1 Осмотр

Каждого пациента с подозрением на фурункул носа первично осматривает оториноларинголог, врач общей практики или педиатр, чтобы поставить и уточнить диагноз.

При передней риноскопии сначала может определяться остиофолликулит преддверия носа — покраснение и уплотнение в устье волосяного фолликула. В течение 1–2 суток появляются отёк, инфильтрат и покраснение кожи входа в нос (стадия инфильтрации), затем кожа истончается, ткани в очаге гнойно-некротически расплавляются и образуется детрит. Снаружи видны покраснение, отёк и болезненность преддверия и кончика носа; пациенту больно, когда касаются носа и во время риноскопии. Кожу преддверия могут покрывать толстые жёлтые корки. При выраженном воспалении отёк переходит на щёку и верхнюю губу.

Основной инструментальный метод — передняя риноскопия; её проводят всем пациентам, чтобы осмотреть полость носа и уточнить, где расположен фурункул.

3.2 Признаки внутричерепных осложнений

При каждом осмотре проверяют, нет ли симптомов внутричерепных осложнений. О них говорят три синдрома: инфекционный, неврологический и офтальмологический.

Инфекционный синдром — это синдром системной воспалительной реакции: температура 38 °C и выше или 36 °C и ниже, частота сердечных сокращений 90 в минуту и больше, частота дыхания больше 20 в минуту, лейкоциты больше 12 × 10^9/л или меньше 4 × 10^9/л либо незрелых форм больше 10%, прокальцитонин плазмы 0,5 нг/мл и выше.

Неврологический синдром — сильная головная боль, тошнота и рвота, не связанные с едой, несистемное головокружение. О менингеальном синдроме говорят светобоязнь, звукобоязнь, повышенная чувствительность кожи и ригидность затылочных мышц; могут определяться симптомы Кернига и Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева и симптом Менделя. По мере прогрессирования возможны оглушение, психомоторное возбуждение и судороги.

Офтальмологический синдром — отёк век, хемоз и экзофтальм на стороне поражения; при пальпации век могут прощупываться болезненные тромбированные вены. При офтальмоскопии бывают признаки внутричерепной гипертензии.

При тромбозе угловой вены пальпация резко болезненна, беспокоит сильная головная боль, лицо отекает на стороне поражения, а сама угловая вена прощупывается как плотный болезненный тяж.

Для тромбоза кавернозного синуса, особенно в начале, характерен выраженный цианоз слизистой губ, кожи лба и носа. Затем нарастает отёк верхней губы и щеки на стороне поражения, который переходит на височную и лобную области, на веки и на другую половину лица. Нарушается, вплоть до полного выпадения, функция глазодвигательного, блокового, отводящего и тройничного нервов.

При подозрении на тромбоз кавернозного синуса делают компьютерную томографию (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.

На возможный тромбоз кавернозного синуса указывают фебрильная лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и признаки поражения III, IV, V и VI пар черепных нервов.

При осложнённом течении пациента первично осматривают офтальмолог и невролог — для дифференциальной диагностики и выбора лечения.

Если воспаление распространилось на лицо, целесообразна консультация челюстно-лицевого хирурга.

По алгоритму КР при внутричерепных осложнениях пациента консультируют нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

> Состав консультантов при осложнениях в КР не совпадает: в разделе 2.5 и в критериях качества — невролог и офтальмолог, а в алгоритме (приложение Б) — нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

3.3 Анализы

На любой стадии всем пациентам делают развёрнутый общий анализ крови, чтобы оценить общее состояние и выраженность воспаления.

Биохимический анализ крови назначают, чтобы выявить сахарный диабет, нарушения углеводного обмена и другие состояния, которые способствуют фурункулу и утяжеляют его течение.

Сахарный диабет ухудшает частоту, течение и прогноз фурункула. При повышенной глюкозе пациента направляют к эндокринологу, чтобы скорректировать глюкозу, выявить диабет и назначить лечебное питание. Изменения билирубина, креатинина, мочевины, АЛТ и АСТ указывают на нарушение работы печени и почек.

Коагулограмму делают всем пациентам с осложнённым фурункулом носа и с сопутствующими болезнями.

При абсцедирующем фурункуле, карбункуле и абсцессе носа гнойное отделяемое отправляют на посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, чтобы правильно выбрать антибиотик.

Материал берут из раны после вскрытия, не касаясь окружающих тканей, и до начала антибиотиков.

---

4. Лечение

Метод лечения выбирают по стадии фурункула и его проявлениям — есть ли карбункул или абсцесс. При неосложнённом течении лечат в основном консервативно, местно и парентерально. Лечение комплексное: уничтожить возбудителя, снять интоксикацию, восстановить обмен веществ и повысить защитные силы организма.

По алгоритму КР в стадии инфильтрации проводят консервативное лечение, в стадии абсцедирования — хирургическое вместе с консервативным. В стадии разрешения пациента консультирует физиотерапевт, при рецидиве — эндокринолог и аллерголог-иммунолог.

4.1 Местное лечение

Всем пациентам с фурункулом носа местно применяют антисептики, чтобы подавить инфекцию и воспаление.

В первые часы после появления инфильтрата хорошо помогает повторное смазывание пустулы 5% спиртовым раствором йода. Выраженно действуют четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), препараты йода (повидон-йод — детям старше 28 дней) и хлоргексидин; их можно применять у взрослых и детей. Как часто обрабатывать рану, зависит от выраженности воспаления; обрабатывают до разрешения инфекции. В стадии инфильтрации кожу вокруг очага бережно обрабатывают 70% этанолом.

Пациентам с фурункулом и карбункулом носа назначают мази с антибиотиками широкого спектра, чтобы санировать очаг.

Мупироцин в мази взрослым наносят 2–3 раза в день 5–7 дней, детям — с рождения 2–3 раза в день не дольше 10 дней. Фузидовую кислоту взрослым наносят на кожу над фурункулом в виде мази или крема до 3–4 раз в день 7–14 дней, детям с рождения — крем 3–4 раза в день 7–14 дней. Мазь диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол действует и противомикробно, и противовоспалительно; взрослым и детям с года её наносят раз в день, пока рана не очистится от гнойно-некротических масс.

4.2 Обезболивание

Если нет противопоказаний, назначают противовоспалительные и обезболивающие средства, чтобы снять воспаление и боль.

Применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и другие анальгетики-антипиретики по отдельности или вместе. Хорошо действует сочетание НПВП с парацетамолом, а для снятия боли у взрослых и детей, в том числе после операции, — метамизол натрия. Из НПВП у детей можно применять ибупрофен с 3 месяцев, кетопрофен с 15 лет, а кетопрофен в гранулах для раствора внутрь — с 6 лет.

Детям в амбулаторной практике метамизол натрия не назначают, а в стационаре применяют, только если нет других разрешённых детям анальгетиков, — из-за риска серьёзных нежелательных явлений.

4.3 Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	0,5–1 г внутривенно, инфузия 15 минут	6 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 «мл» внутримышечно (так в таблице КР; по смыслу — 75 мг)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно или внутримышечно	8 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	не больше 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> Разовая доза диклофенака в таблице 1 записана как «75 мл в/м»; по смыслу и по суточному максимуму 150 мг речь о 75 мг.

4.4 Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия 15 минут: меньше 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; больше 50 кг — 1000 мг	4 ч	Меньше 10 кг — меньше 30 мг/кг; 10–50 кг — меньше 60 мг/кг, но не больше 2 г; 33–50 кг — меньше 60 мг/кг, но не больше 3 г; больше 50 кг — 4 г	5–7 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутрь	С 12 лет — 0,5–1 г; 6–12 лет — 240–480 мг; 1–6 лет — 120–240 мг; от 3 месяцев до года — 72–120 мг	6 ч	С 12 лет — 4 г; 33–50 кг — меньше 60 мг/кг, но не больше 3 г; 10–50 кг — меньше 60 мг/кг, но не больше 2 г; меньше 10 кг — меньше 30 мг/кг	С 12 лет — 3 суток, до 12 лет — 5–7 суток
Парацетамол в ректальных суппозиториях	10–14 лет — 500 мг; 5–9 лет — 250 мг; 1–4 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50–100 мг	4–6 ч	Меньше 60 мг/кг	До 5 суток
Ибупрофен внутрь	Старше 6 лет — 200–400 мг; 4–6 лет — 150 мг; 1–3 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50 мг	8 ч	12–17 лет — 1 г; 6–12 лет — 800 мг; 4–6 лет — 450 мг; 1–3 года — 300 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 3–6 месяцев — 150 мг	4 суток
Ибупрофен в ректальных суппозиториях	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	8 ч (3–9 месяцев), 6 ч (9–24 месяца)	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	Не больше 3 суток
Кетопрофен	С 15 лет — 100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	Не больше 2 суток
Кетопрофен в гранулах для раствора внутрь	Старше 6 лет — 40 мг	8 ч	120 мг	Не больше 2 суток
Метамизол натрия внутримышечно	13–14 лет — 0,8–1,8 мл (400–900 мг); 10–12 лет — 0,5–1,0 мл (250–500 мг); 7–9 лет — 0,4–1,0 мл (200–500 мг); 4–6 лет — 0,3–0,8 мл (150–400 мг); 1–3 года — 0,2–0,5 мл; 3–11 месяцев — 0,1–0,2 мл (50–100 мг)	8–12 ч	С 15 лет — 2 г; 8–14 лет — 900 мг; 4–7 лет — 600 мг; 2–3 года — 300 мг	1–5 суток

> В строке метамизола натрия таблицы 2 для детей 1–3 лет указано «0,2–0,5 мл (100–2500 мг)»: при тех же 500 мг в 1 мл, что и в соседних строках, 0,5 мл — это 250 мг, так что «2500» — опечатка. Возраст «79 лет» в той же строке — это 7–9 лет.

4.5 Системные антибиотики

Системные антибиотики назначают всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа, чтобы санировать очаг инфекции и предупредить осложнения.

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет или с массой больше 40 кг дают амоксициллин с клавулановой кислотой по 1000 мг (875/125) 2 раза в сутки 7 дней. Детям от 3 месяцев до 12 лет с массой меньше 40 кг назначают суспензию (400 мг амоксициллина + 57 мг клавулановой кислоты в 5 мл) из расчёта 20 мг/кг в сутки, новорождённым и детям до 3 месяцев — 30 мг/кг по амоксициллину 2 раза в день, 7–14 дней. С 12 лет можно цефдиторен по 200 мг каждые 12 часов 10 дней.

При тяжёлом или рецидивирующем фурункуле и при непереносимости бета-лактамов с 18 лет назначают левофлоксацин 750 мг раз в сутки 7–14 дней или моксифлоксацин 400 мг раз в сутки 7 дней.

Из парентеральных препаратов первая линия — цефазолин: взрослым 0,5 г внутривенно или внутримышечно 2 раза в день, детям от месяца до 18 лет — 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, 7–10 дней. Цефтриаксон взрослым и детям старше 12 лет или тяжелее 50 кг вводят по 1–2 г раз в сутки; новорождённым до 14 дней — 20–50 мг/кг раз в сутки, не больше 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг раз в сутки, 7–10 дней.

Ампициллин с сульбактамом вводят внутримышечно или внутривенно (капельно 60–80 капель в минуту или струйно медленно за 3–5 минут): взрослым 3–12 г в сутки в 3–4 введения по тяжести инфекции, детям 150 мг/кг в сутки в 3–4 введения, недоношенным и детям первой недели жизни — 75 мг/кг в сутки в 2 введения, 5–14 дней. Амоксициллин с клавулановой кислотой внутривенно взрослым и детям старше 12 лет вводят по 1 г по амоксициллину 3 раза в сутки; детям до 3 месяцев и с массой меньше 4 кг — 25/5 мг/кг каждые 8 часов, только медленной инфузией за 30–40 минут; от 3 месяцев до 12 лет — 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов по тяжести инфекции, 5–14 дней.

Клиндамицин назначают при аллергии на бета-лактамы: взрослым парентерально 0,6–2,7 г в сутки в несколько введений, детям 3–18 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 3–4 равных приёма, 7–10 дней. Детям младше 3 лет он противопоказан.

4.6 Парентеральные антибиотики

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Цефазолин	Взрослым 0,5 г; детям старше месяца 10–20 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям старше месяца 100 мг/кг	7–10 дней
Цефтриаксон	Взрослым 1–2 г; новорождённым до 14 дней 20–50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	1 раз в сутки	Взрослым 4 г, детям 2 г	7–10 дней
Ампициллин + сульбактам	Взрослым 1–2 г; детям старше месяца 50 мг/кг; новорождённым до 14 дней 75 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	Взрослым и детям старше месяца 3 раза, новорождённым 2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям 150 мг/кг	5–14 дней внутримышечно (или 5–7 дней внутривенно, затем внутримышечно до 14 дней)
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослым и детям старше 12 лет 1 г внутривенно; до 12 лет 25 мг/кг внутривенно	Взрослым и детям старше 3 месяцев 3 раза, детям до 3 месяцев 2–3 раза в сутки	Взрослым и детям старше 12 лет 6 г, до 12 лет 50–75 мг/кг	5–14 дней

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Клиндамицин	Взрослым «0,2–0,9 мг» (так в таблице; внутримышечно не больше 0,6 г, внутривенно не больше 1,2 г на введение); детям 3–18 лет 5–10 мг/кг внутримышечно или внутривенно	3–4 раза в сутки	Взрослым 4,8 г, детям 40 мг/кг	7–10 дней

Текст раздела 3.1 и таблица 3 расходятся. Цефазолин детям: в тексте 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в таблице — 10–20 мг/кг 2 раза в сутки. Ампициллин с сульбактамом: в тексте взрослым до 12 г в сутки, в таблице максимум 6 г; новорождённым в тексте 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в таблице 75 мг/кг на введение 2 раза в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 25 мг/кг каждые 6–8 часов (до 100 мг/кг в сутки), в таблице максимум 50–75 мг/кг в сутки. Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице указана в миллиграммах («0,2–0,9 мг»), хотя по смыслу и по тексту (0,6–2,7 г в сутки) это граммы.

4.7 Антикоагулянты

При осложнённом течении фурункула, карбункула или абсцесса носа всем пациентам для профилактики тромбозов назначают антикоагулянты прямого или непрямого действия.

Дозу подбирают по показателям свёртываемости крови.

4.8 Хирургическое лечение

Оперируют фурункул носа только при абсцедировании, а также карбункул носа.

При осложнённом течении абсцесс или карбункул носа вскрывают, чтобы эвакуировать гной и обеспечить дренирование.

Оперируют под местным или общим обезболиванием. Материал из раны на бактериологическое исследование берут обязательно.

В стадии разрешения пациента консультирует физиотерапевт, чтобы ускорить выздоровление.

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 Рецидивы

При рецидивирующих фурункулах носа пациента консультирует эндокринолог (ребёнка — детский эндокринолог), чтобы найти причину рецидивов.

В ряде случаев целесообразна и консультация аллерголога-иммунолога.

При рецидивирующем фурункуле носа для профилактики рецидивов назначают бактериофаги.

Местно бактериофаги оправданы в комплексном лечении, если выделенные штаммы устойчивы к антибиотикам, если в анамнезе было больше двух курсов антибиотиков, при непереносимости антибиотиков и при рецидивах.

5.2 Профилактика

Главное в профилактике фурункула и его осложнений — личная гигиена: мыть руки до и после еды, после туалета, транспорта и общественных мест. Важна и гигиена труда — защитные средства при пыльной и грязной работе. Нельзя трогать лицо, особенно нос, грязными руками, массировать болезненные места, выдавливать фурункул и лечиться самостоятельно. При сахарном диабете и других сопутствующих болезнях важно соблюдать диету и вовремя принимать лекарства. Гигиене учат в семье, детском саду и школе.

Пациенту объясняют, что нужно осторожно относиться к косметическому уходу за лицом, включая чистку лица и бритьё, и что при гнойничке на коже носа или верхней губы категорически нельзя массировать его и выдавливать. Родители следят за чистотой рук ребёнка, учат его правильно чистить нос и не давать ковырять в носу. При отёке или покраснении в области фурункула пациенту советуют обращаться в ЛОР-стационар.

5.3 Госпитализация

У детей сам диагноз абсцесса, фурункула или карбункула носа — показание к госпитализации в круглосуточный ЛОР-стационар. Взрослых в стадии инфильтрации можно лечить у оториноларинголога амбулаторно. Пациентов с фурункулом в стадии инфильтрации и сопутствующими болезнями и пациентов с рецидивирующими фурункулами КР упоминает отдельно, но действие для них не указано. В большинстве случаев лечит оториноларинголог в хирургическом стационаре.

> В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими болезнями и рецидивирующими фурункулами оборвана: не сказано, что с ними делать, — по контексту, видимо, госпитализировать. Кроме того, в информации для пациента (приложение В) всем, у кого есть отёк или покраснение в области фурункула, советуют обращаться в ЛОР-стационар, хотя покраснение и отёк есть уже в стадии инфильтрации, при которой взрослых, по разделу 6, можно лечить амбулаторно.

Выписывают при положительной динамике и отсутствии осложнений: когда абсцесс, фурункул или карбункул разрешился, общее состояние удовлетворительное и температура нормализовалась.

При неосложнённом течении прогноз благоприятный. У пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом и с сахарным диабетом следует ждать более тяжёлого течения и высокого риска осложнений.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	956_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.6 фурункул располагается «в области дна носа у нижней губы», в определениях — «у верхней губы».
- В таблице 1 разовая доза диклофенака записана как «75 мл».
- В таблице 2 у метамизола натрия для детей 1–3 лет указано «100–2500 мг» (по объёму 0,2–0,5 мл должно быть 100–250 мг), а возраст «79 лет» означает 7–9 лет.

- Дозы антибиотиков в тексте раздела 3.1 и в таблице 3 не совпадают: цефазолин у детей, максимальная доза ампициллина с сульбактамом у взрослых и его доза у новорождённых, суточная доза амоксициллина с клавулановой кислотой у детей.
- Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице 3 указана как «0,2–0,9 мг» вместо граммов; в тексте фраза «противопоказан детям в возрасте старше до 3-х лет» искажена (по контексту — младше 3 лет).
- Цефдиторену приписан код АТХ N07AX02, левофлоксацину — неполный код J01MA.
- Состав консультантов при внутричерепных осложнениях в разделе 2.5 и критериях качества (невролог, офтальмолог) не совпадает с алгоритмом в приложении Б (нейрохирург, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург).
- В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими болезнями и рецидивирующими фурункулами не закончена; совет из приложения В обращаться в стационар при любом отёке или покраснении расходится с возможностью амбулаторного лечения взрослых в стадии инфильтрации.
- Хирургическое лечение описано по-разному: в разделе 3.2 — при абсцедировании и при карбункуле, в рекомендации — «при осложнённом течении», в критериях качества — при стадии абсцедирования.
- Раздел «Иное лечение» пронумерован как 4 вместо 3.3, поэтому номер 4 повторяется дважды.
- В комментарии о бактериофагах упомянута «комплексная терапия ОС» — сокращение в КР не расшифровано и к фурункулу носа, по-видимому, не относится.